PROTOCOLLO 44

Trigger point dello sternocleidomastoideo

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dallo sternocleidomastoideo

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a fronte, orbita, orecchio e mandibola
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Dolore al volto e all'orecchio

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa il ventre sternale e clavicolare con presa a pinza e individua la banda tesa.



Compressione ischemica

Afferra il muscolo tra pollice e indice con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sull'arteria carotide
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Allungamento dello SCM	Inclinazione controlaterale e rotazione omolaterale mantenuta	3 x 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Il dolore riferito dello SCM al volto e all'orecchio è spesso confuso con un DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.